

12~16 ★★★	薬剤性肺障害の発症に関連するリスクはどれか。
12 ☑☑☑	原因となる薬剤の摂取歴がある。
13 ☑☑☑	薬剤に起因する臨床病型の報告がある。
14 ☑☑☑	他の原因疾患が否定される。
15 ☑☑☑	薬剤の中止により病態が改善する。
16 ☑☑☑	再投与により増悪する確認が必須である。
17★★★ ☑☑☑	薬剤性肺障害の血液検査では末梢血白血球数が減少する。
18★★★ ☑☑☑	血清 C 反応性蛋白 (CRP) や乳酸脱水素酵素 (LDH) が上昇する。
19★★★ ☑☑☑	血清 Krebs von den Lungen-6 (KL-6)、surfactant protein A (SP-A) や SP-D は診断補助や病勢モニタリングに有用である。
20★★★ ☑☑☑	DAD パターンでは血清 KL-6、SP-D、SP-A が上昇する。
21★★★ ☑☑☑	器質化肺炎 (OP) パターンでは血清 KL-6 は上昇するが、SP-D、SP-A は正常であることが多い。
22★★★ ☑☑☑	薬剤リンパ球刺激試験 (drug induced lymphocyte stimulation test: DLST) は患者の末梢血中 T リンパ球と被疑薬を混合して T リンパ球への ³ H-thymidine の取り込みを測定することで、T リンパ球の増殖能を定量評価する検査である。
23★★★ ☑☑☑	DLST の薬剤性肺障害全体の陽性率は 30% 程度である。
24★★★ ☑☑☑	DLST の偽陽性率、偽陰性率は低い。
25★★★ ☑☑☑	薬剤性 DAD パターンでは広範な浸潤影やすりガラス陰影に牽引性気管支拡張などの構造改変所見がみられるのが特徴である。